

目录

第 1 章	为什么学习健康经济学? 1
1.1	健康经济学的重要(并不是唯一的)层面 2
1.2	市场如何与医疗服务和健康保险相互联系 6
1.3	再次思考 22
1.4	结语 22
1.5	《健康经济学手册》中的相关章节 22
1.6	问题 22
第 2 章	效用和健康 25
2.1	如何看待健康和卫生保健(或健康经济学?) 26
2.2	健康生产 28
2.3	生命周期中的健康 29
2.4	一个关于消费和健康的模型 31
2.5	结语 40
2.6	《健康经济学手册》中的相关章节 40
2.7	问题 40
	附录:效用最大化的正式模型 41
第 3 章	卫生保健到健康的转变 43
3.1	卫生保健的生产率 44
3.2	生产函数的困惑:一个政策难题 57
3.3	医生的特定变异(医疗实践风格) 63
3.4	扩展边际和集约边际的差异:它们是相似的吗? 66
3.5	结语 67
3.6	《健康经济学手册》中的相关章节 68
3.7	问题 68
	附录:边际、平均和总生产率 69
第 4 章	卫生保健需求的概念框架 72
4.1	健康和其他商品的无差异曲线 73
4.2	从无差异曲线到需求曲线 77
4.3	疾病事件如何影响需求曲线 78
4.4	多种卫生保健的需求曲线 78
4.5	社会需求曲线:合计个人需求 79

4.6	使用需求曲线衡量卫生保健价值	80
4.7	保险如何影响卫生保健需求曲线	81
4.8	时间成本和交通成本	88
4.9	质量在卫生保健需求中的作用	89
4.10	回顾:卫生保健价格指数	92
4.11	结语	92
4.12	《健康经济学手册》中的相关章节	93
4.13	问题	93
	附录:需求曲线和需求弹性	94

第5章 卫生保健需求与应用的实证研究 97

5.1	需求曲线相关研究	98
5.2	另一项随机研究:俄勒冈贫困医疗补助保险(Medicaid)试验	105
5.3	患者的性别和年龄对需求的影响	106
5.4	患病对需求的影响	107
5.5	生活方式及其对需求的影响	107
5.6	“疾病”的需求	109
5.7	处方药保险的进一步讨论	111
5.8	关于卫生保健需求的其他研究	114
5.9	需求理论的应用与拓展	116
5.10	决策理论:引出“正确”卫生保健需求曲线	119
5.11	成本效益比和需求曲线	119
5.12	医疗实践中为什么会有差异?	120
5.13	结语	120
5.14	《健康经济学手册》中的相关章节	121
5.15	问题	121
	附录:卫生决策理论的一个例子	122

第6章 医生与医生公司 127

6.1	“公司”——投入、产出和成本	128
6.2	作为企业家的医生	129
6.3	医生公司及其生产函数	129
6.4	医生作为诊断者	130
6.5	非医生初级保健提供者	134
6.6	公司规模:医学团体实践	136
6.7	执业所有权模式	139
6.8	医生作为劳动力	140
6.9	总供给曲线:进入和退出	144
6.10	开放经济:美国和国际培训的医生	144

6.11	结语	146
6.12	《健康经济学手册》中的相关章节	147
6.13	问题	147
	附录:成本转嫁	148
第 7 章	市场中的医生	151
7.1	医生执业地点的选择	152
7.2	消费者搜寻与市场均衡	157
7.3	不完全搜寻的后果	166
7.4	患者的实际搜寻	167
7.5	广告和信息成本	168
7.6	许可的作用	169
7.7	医生公司面临的需求曲线估计	170
7.8	诱导需求	171
7.9	付款计划的作用	177
7.10	结语	178
7.11	《健康经济学手册》中的相关章节	179
7.12	问题	179
第 8 章	医疗服务的提供者——医院	182
8.1	医院组织	183
8.2	谁是剩余索取权人?	186
8.3	效用函数来自哪里?	189
8.4	医院成本	192
8.5	长期成本与短期成本	195
8.6	医院的“成本曲线”	195
8.7	门诊手术重塑了医院部门	197
8.8	单个医院面对的需求曲线	199
8.9	重新审视效用最大化的医院管理者	200
8.10	结语	200
8.11	《健康经济学手册》中的相关章节	201
8.12	问题	201
第 9 章	市场中的医院	204
9.1	医院和医务人员市场	205
9.2	医院和患者	206
9.3	质量与价格均衡模型	207
9.4	医院决策中的保险和竞争	209
9.5	医院与医生的互动:医生的“利益”	211

	9.6 医生与医院的互动:医院患者	212
	9.7 竞争:“旧模式”与“新模式”	213
	9.8 进入和退出:营利性医院的关键作用	214
	9.9 劳动力市场中的医院	215
	9.10 护士“短缺”	216
	9.11 结语	218
	9.12 《健康经济学手册》中的相关章节	219
	9.13 问题	219
	附录:医院关于产量和质量的决策	220
第 10 章	医疗保险需求	223
	10.1 医疗保险需求	225
	10.2 保险需求原因	225
	10.3 保险的选择	228
	10.4 投保预防服务	232
	10.5 保险市场稳定:自我选择问题	234
	10.6 医疗保险所得税补贴	240
	10.7 保险需求的经验估计	244
	10.8 税收补贴对卫生部门的总体影响	245
	10.9 “最优”保险	246
	10.10 其他保险需求模型	246
	10.11 总结	247
	10.12 《健康经济学手册》中的相关章节	248
	10.13 问题	248
	附录	250
	附录 A:福利损失的详细计算	250
	附录 B:道德风险权衡的计算	251
	附录 C:保险池的统计分析	252
第 11 章	医疗保险供给和管理式医疗	256
	11.1 保险的供给	256
	11.2 PPACA 中的保险交易所	260
	11.3 管理式医疗:对传统保险激励措施的回应	262
	11.4 为什么是管理式医疗?	264
	11.5 市场份额趋势	265
	11.6 干预类型	268
	11.7 哪些干预措施对于管理式医疗最有效?	276
	11.8 长期问题	277
	11.9 结语	280

11.10	《健康经济学手册》中的相关章节	281
11.11	问题	281
第 12 章	医疗保险的政府供给	283
12.1	Medicare 计划	285
12.2	适当的起付线	286
12.3	随时间增多的附加项目	287
12.4	Medicare 运作上的变化	294
12.5	医疗救助计划项目 Medicaid	305
12.6	结语	309
12.7	《健康经济学手册》中的相关章节	309
12.8	问题	309
第 13 章	医疗事故	313
13.1	美国法律体系的背景	314
13.2	过失法在经济逻辑	318
13.3	司法错误、防御性医疗和“硬汉形象”	319
13.4	医疗事故保险	321
13.5	关于实际威慑作用的证据	321
13.6	医疗事故赔偿：“闪电”还是“定点清扫”	330
13.7	侵权法改革	331
13.8	侵权法改革能多大程度降低医疗费用	333
13.9	最为明显的侵权法改革	334
13.10	结语	335
13.11	《健康经济学手册》中的相关章节	335
13.12	问题	335
第 14 章	健康和卫生保健的外部性	338
14.1	外部性、财产权和外部性的控制	339
14.2	传染病的外部性	340
14.3	外部性问题的解决方案	345
14.4	国际化问题：扩大外部性影响范围	346
14.5	烟草的外部性	348
14.6	信息的外部性	349
14.7	研究的外部性	351
14.8	医疗有效性研究缺乏的原因	352
14.9	输血诱发的艾滋病和肝炎	352
14.10	结语	354
14.11	《健康经济学手册》中的相关章节	354

	14.12 问题	355
	附录:生命的价值	355
第 15 章	管理市场:管制、质量认证和技术变革	359
	15.1 管制分类	360
	15.2 许可证	361
	15.3 质量测量	364
	15.4 根据结果支付:PPACA 中的 ACO	366
	15.5 “需求认证”法	367
	15.6 价格控制	369
	15.7 Medicare 价格控制	370
	15.8 药物和设备:卫生保健的新浪潮	377
	15.9 结语	388
	15.10 《健康经济学手册》中的相关章节	389
	15.11 问题	389
第 16 章	全民医保问题和国际卫生保健系统的比较	393
	16.1 国际对比汇总	395
	16.2 费用增加与健康产出	399
	16.3 患者保护和平价医疗法案	404
	16.4 关于国家卫生政策的总体思考	407
	16.5 终极难题	415
	16.6 总结	415
	16.7 《健康经济学手册》中的相关章节	416
	16.8 问题	416
	作者附言	418
	参考文献	420